إصابات الرأس والعمود الفقري



<u>إصابات الرأس يمكن أن تكون</u>:

جروح في فروة الرأس
إصابات بالمخ
كسور بعظام الجمجمة

<u>أسباب إصابات الرأس والعمود الفقري</u>

حوادث السيارات -الوقوع من ارتفاع -الرياضة مثل الغطس

<u>الإسعافات الأولية لإصابات الرأس:</u>

لا تحرك المصاب.
ثبت الرأس والرقبة في موضع الإصابة.
أوقف النزيف وحاول السيطرة عليه.
قم بتأمين مجرى الممرات الهوائية بحيث تكون مفتوحة.
أعط الأكسجين إن وجد
لاحظ العلامات الحيوية ، مدى فقد الوعي ومدته ، التشنجات
قم بتدفئة
تعتبر كسور العمود الفقري من الكسور الخطيرة إذ قد ينتج عنها إصابة النخاع الشوكي *** .والتي قد تؤدي إلى حدوث شلل مستديم

<u>في حالة كسر العنق والعمود الفقري يجب</u>:

تركيب "ياقة طبية"قبل نقله .وينقل بعناية على لوح خشبي بأكثر من فرد ككتلة واحدة.



كيفية تثبيت حركة الرأس والرقبة:

-ضع يدك على جانبي رأس المصاب في الوضع الطبيعي.
-نقل المصاب يقوم به أربعة مسعفين على الأقل.
-إذا توفرت رقبة بلاستك يكوك هذا أفيد

الدوخة

هي شعور بدوران كل ما يحيط بك، وقد يحس المصاب بأن الغرفة تلف به أو بأن الدوران موجود داخل رأسه أو جسده.

وعادة ما تترافق الدوخة مع مشاكل في الأذن الداخلية التي تملك جهازاً فائق الحساسية تجاه الحركة. وعند إصابتها بآفة جرثومية أو رضخ أو اضطرابات أخرى، يرسل الجهاز رسالة خاطئة إلى الدماغ.

فقدان التوازن

فهو الشعور بأن عليك لمس شيء أو التمسك به لتحافظ على توازنك.

ومن شأن الفقدان الحاد للتوازن أن يجعل من الصعب تلافي السقوط.

الإغماء (Fainting)

عبارة عن مصطلح يشير إلى الفقدان المفاجئ والمؤقت لوعي الإنسان، وعادة ما يكون نتيجة انخفاض مستوى الأكسجين الواصل إلى الدماغ.

للأكسجين أهمية كبيرة في جسم الإنسان، وعدم وصوله إلى المناطق المختلفة من شأنه أن يسبب الضرر، تماماً مثلما يحدث في حالة الإغماء.

المقصود هنا، عندما يقل تدفق الدم والأكسجين إلى الدماغ بشكل حاد، يقوم الدماغ بوقف عمل

جميع أجزاء الجسم غير الحيوية، لتتركز الطاقة الشحيحة المتبقية في عمل الأعضاء الأساسية في الجسم.
فعندما يلاحظ الدماغ أن مستوى الأكسجين قد قل، يحدث في الجسم الأمور التالية:
تبدأ بالتنفس بسرعة، في محاولة لتعويض هذا النقص
يرتفع معدل نبضات القلب في محاولة لإيصال الأكسجين إلى الدماغ
نتيجة لذلك ينخفض ضغط الدم لدى المصاب في الأعضاء الأخرى من الجسم
يحصل الدماغ على كمية فائضة من الدم المحمل بالأكسجين على حساب الأعضاء الأخرى
التنفس الزائد المترافق مع انخفاض ضغط الدم، يؤديان إلى فقدان الوعي المؤقت وضعف عضلات الجسم.

أسباب الإصابة بالإغماء

كما أسلفنا فإن السبب الرئيسي للإصابة بالإغماء ناتج عن نقص وصول الأكسجين إلى دماغ الإنسان.
هذا الأمر يسببه عدة أمور، أهمها:
مشاكل في الرئتين
مشاكل في الدورة الدموية لدى المصاب
التسمم بأول أكسيد الكربون
أسباب أخرى:
أولاً: أسباب متنوعة إضافية تسبب حدوث الإغماء
تتنوع الأسباب التي قد تؤدي لإصابة الشخص بالإغماء لتشمل:
مؤثرات وصدمات نفسية/عاطفية: رؤية مشاهد صدمية (مثل الدماء)، التواجد في تجارب غير محببة، الصدمات الانفعالية الناتجة عن الأخبار السيئة، أو التوتر الشديد والإحراج.
عوامل ميكانيكية ووظيفية: الوقوف الطويل بدون حركة، أو الانتقال السريع والمفاجئ من وضعية الجلوس إلى الوقوف.
عوامل بيئية وبدنية: التواجد في أماكن مزدحمة وحارة لفترات طويلة، أو الإجهاد البدني الشديد
حالات مرضية واستقلابية: الجفاف، اضطراب مستويات السكر في الدم لدى مرضى السكري، بعض أمراض القلب، أو الإفراط في تناول الكحول خلال فترة زمنية قصيرة.
ثانياً: أعراض ومراحل ما قبل حدوث الإغماء
يمر المصاب قبل فقدان الوعي بعدة علامات وأعراض متدرجة:
*الشعور بثقل القدمين والارتعاش
ينخفض ضغط الدم ومستوى الكالسيوم فيه، مما يسبب وخزاً في الأطراف والأعصاب ورعشة خفيفة.
التصرف الإسعافي: فتح مجرى الهواء للمصاب وإزالة أي عائق يمنع التنفس السليم، لتسهيل ضخ الدم للأطراف.
*اللهث والتنفس السريع :يحاول المصاب التقاط الأنفاس بصعوبة قبل السقوط.
التصرف الإسعافي: الجلوس فوراً والاستلقاء مع وضع اليد على البطن والتنفس ببطء

*توهج وغباش الرؤية:
تقل حدة الرؤية وتنغلق حدقة العين تدريجياً:
التصرف الإسعافي: جلوس المصاب وضع رأسه بين ركبتيه للمساعدة في إعادة تدفق الدم إلى الدماغ
*الارتباك والشعور بالحر
*الدوار والدوخة الشديدة
ينجم عن الهبوط المفاجئ في ضغط الدم
التصرف الإسعافي: شد أو الضغط على عضلات الجزء السفلي (الفخذين أو الساقين) عند استشعار الدوار.
أعراض أخرى مترافقة:
*الغثيان والرغبة في القيء و*التعرق الزائد والتثاؤب المستمر
شحوب البشرة: يتحول لون الوجه إلى الأصفر نتيجة الشحوب؛ ويجب حينها تأمين هواء نقي وجعل المصاب يجلس بوضعية صحيحة
ثالثاً: تصنيف أنواع الإغماء
إغماء موضعي: وينتج بالأساس عن تراجع وانخفاض تدفق الدم وضغطه في المخ
إغماء مرضي:
يكون سببه أمراض في القلب والأوعية الدموية، أو مشاكل في الجهاز العصبي والمخ.
الإغماء المفاجئ
يحدث الإغماء مباشرة بعد انخفاض ضغط الدم المفاجئ، إنما تظهر بعض العلامات أولاً قبل أن يسقط الشخص أرضاً، لذا عليك معرفة هذه العلامات لتأخذ احتياطك لتجنب الإصابة:
الإسعافات الأولية لحالات الإغماء
التأكد من بقاء مسلك الهواء مفتوحاً لدى المصاب بحالات الإغماء
أن يتنفس المصاب بشكل جيد، ويجب مراقبة النفس في منطقة الصدر والبطن
فك الملابس الضيقة أو ربطة العنق، أو أي شيء يعيق عملية التنفس لدى المصاب
فحص المصاب سريعاً والتفتيش عن أي إصابات خطيرة في جسمه نتيجة السقوط
المصاب في وضع الإفاقة وهو كالآتي:
وضع الإفاقةهو الوضع الذي يبقي مسلك الهواء لدي المصاب مفتوحاً، بحيث لا يسقط اللسان في الحلق، كما يبقي الرأس والعنق مسطحين فيتسع ممر الهواء.
ومن الضروري أن تكون أطراف المصاب في وضع الاستقرار للحفاظ على ثبات الجسم، ويظل في وضعية آمنة ومريحة.
في حال شعورك بالإغماء
والمقصود هنا ظهور الاعراض ما قبل الإغماء، في هذه الحالة من المهم القيام بما يلي
اعثر على مكان لتجلس فيه
عند جلوسك يجب وضع الرأس بين ركبتيك .
عندما تشعر بتحسن، ارفع رأسك رويداً رويداً.

Shock الصدمة

الصدمة هي الاضطراب الناجم عن نقص تروية أنسجة الجسم المختلفة بالدم الحامل للأكسجين والغذاء مما يؤثر على الوظيفية الخلوية الفيسيولوجية ويتسبب بالموت الخلوي يتبعه الفشل العضوي والفشل الجهازي بأكمله والوفاة.

تعد الصدمة حالة طبية طارئة تهدد حياة المصاب مما يتطلب التدخل العلاجي الفوري.

تصنف الصدمة اعتماداً على عاملها المسبب الى:

a-صدمة قلبية المنشأ

b-صدمة نقص حجم الدم

c-صدمة الانتائية

d-صدمة عصبية

ترتبط الاصابة بالصدمة بالاضطرابات المرضية التي تؤثر في التدفق الطبيعي للدم ومنه:

أمراض القلب (فشل القلب، النوبة القلبية

انخفاض حجم الدم المرتبط بالنزيف الحاد او الجفاف

اضطرابات الأوعية الدموية المرتبطة بتفاعلات التحسس المزمنة أو العدوى

العقاقير الدوائية التي تقلل من الوظيفة الفيسيولوجية للقلب أو تخفض ضغط الدم

اصابة النخاع الشوكي.

يتم التمييز، عادةً، بين ثلاث مراحل مختلفة في حالة الصدمة، تختلف بدرجة حدتها ومدى خطورتها:

-مرحلة ما قبل الصدمة :فقدان حتى ١٠٪ من حجم الدم، مصحوباً بنبض سريع وانخفاض طفيف في ضغط الدم. في هذه المرحلة تكون الأجهزة الدفاعية في الجسم لا تزال قادرة على التعويض عن خسارة الحجم هذه.

- مرحلة الصدمة :فقدان أكثر من ٢٠٪ من حجم الدم، أو انخفاض ملحوظ في النتاج القلبي (Cardiac output) مصحوباً بانهيار قدرة الأجهزة الدفاعية على التعويض ومن ثم ظهور أعراض الصدمة.

-الصدمة غير القابلة للإصلاح: استمرار حالة الصدمة من دون علاج يسبب ضررا شديدا غير (Irreversible) قابل للعكس في الخلايا والأنسجة ,فشلا مجموعيا وموت المريض.

العلامات والأعراض المرافقة للصدمة:

١-زراق الشفتين وأطراف الأصابع .

٢-ألم الصدر.

٣-الدوار أو الاغماء .

٤-الارتباك والتشويش.

٥-رطوبة،برودة وشحوب الجلد.

٦- فرط التعرق.



٧-انخفاض أو انعدام الناتج البولي.
٨-نبض القلب السريع والضعيف .
٩-التنفس العميق.
١٠-فقدان الوعي.

يشمل إسعاف الاصابة بالصدمة عدد من الاجراءات الاسعافية ومنها:

١-تقييم وعي المُصاب الكافي وقدرته على التنفس بشكل مُستقل أو انسداد الانف او الفم وتعذر التنفس. تقييم عملية تنفس المُصاب وفيما اذا كان بحاجة الى التنفس الاصطناعي

٢-تقييم ضغط الدم الكافي وفيما اذا كان المُصاب بحاجة الى السوائل الوريدية أو العقاقير الدوائية لتعزيز ضغط الدم

٣-السيطرة على النزيف الدموي بالضغط المباشر على موقع النزيف ونقل وحدات الدم في حال فقدان كميات كبيرة منه

٤-التحقق من تركيز الغلوكوز في الدم عن طريق وخز الاصبع للكشف عن عدم انخفاض غلوكوز الدم الحاد.



علاج الصدمة

معالجة حالات الصدمة يجب أن تتم بشكل فوري ودون أي تأخير، من أجل منع تفاقم الحالة وأضرارها. الهدف من العلاج هو تحسين تدفق الدم وتزويد الأنسجة بالأكسجين. ويختلف العلاج باختلاف العامل المسبب الذي أدى إلى حصول الصدمة، ويشمل: معالجة المسبب الأولي الأساسي الذي أدى إلى حصول الصدمة، تحسين تزويد الأنسجة بالأكسجين ومعالجة فشل أجهزة الجسم الناشئ عن الصدمة.

*في حالة صدمة نقص حجم الدم: يجب الحرص على عدم بذل جهد جسماني قوي، من أجل سوائل إلى داخل –(Instillation إدخال العلاج قطرة قطرة) التقليل من فقدان السوائل وتستيل الوريد، تبعا لمستوى ضغط الدم والنبض. يجب العمل على وقف النزيف النشط بواسطة الضغط ، (Arterial tourniquet) الموضعي على مكان الإصابة أو وضع عاصبة شريانية إجراء عملية جراحية لوقف نزيف داخلي و تسريب كريات دم حمراء، في حالة فقدان كمية كبيرة من الدم.

*في حالة الصدمة القلبية المنشأ: الخلود إلى الراحة، الحصول على الأكسجين، معالجة الاضطراب في نظم القلب، تناول أدوية موسعة للأوعية الدموية في عضلة القلب والتي تقلل من الضغط على القلب. تزويد الجسم بماده مذيبة للدم المتخثر الذي سبب الاحتشاء وفتح الأوعية الدمزية عن طريق إدخال قثطار( )أحيانا يستوجب الأمر إجراء عملية جراحية يتم فيها وضع المجازات في الأوعية الدموية المسدودة أو لإصلاح خلل/عيب في الصمام.

*في حالة الصدمة الناتجة عن توسع الأوعية الدموية: يجب تزويد الجسم بالسائل بواسطة التستيل، بسرعة ودون أي تأخير. أعطاء أدوية لتقليص الأوعية الدموية، وإعطاء مصل خاص مضاد لسم اللدغة.

في حالة صدمة التأق: السوائل، الستيرويات والأدرينالين.*

*عندما يكون المسبب للصدمة تلوثا جرثوميا متفشيا، يجب إزالة مصدر التلوث - إعطاء المضاد الحيوي الملائم، إعطاء المريض السوائل والأدوية المقلصة للأوعية الدموية. إذا ظهر المتفاعل C التهاب صعب، فيجب إعطاء المريض ستيرويات بجرعة ضئيلة والبروتين (Proteina C reactiva)



التشنجات

تعريف التشنج:

شلل أو توتر في جميع عضلات الجسم أو جزء منها. وأحيانا تكون مصاحبة لفقدان الوعى أو .يكون المصاب واعياً

أسباب التشنج:

الأطفال تحت سن ٥ سنوات نتيجة ارتفاع شديد في درجة الحرارة.

المرأة الحامل.

مرض الصرع.

اصابات الرأس المصحوبة بنزيف.

علامات وأعراض التشنج:

يسقط المريض مغشيًّا عليه وتتصلب العضلات ، وذلك عدة ثوان إلى نصف دقيقة يحدث بعدها .ارتعاش بنفس العضلات

أثناء فترة التصلب قد يتوقف التنفس ويخرج اللعاب من الفم وقد يفقد السيطرة على البول والبراز.

الإسعافات الأولية:

قم بحماية المصاب من إيذاء نفسه.

ضعه على الأرض مستلقياً على ظهره.

فك الملابس حول الرقبة.

انتظر عدة دقائق حتى تنتهى التشنجات.

اذا تقيأ المصاب ، أدر رأسه لأحد الجانبين.

أثناء التشنجات:

لا تحاول أن توقف التشنجات.

لا تعطى أى شيء بالفم.

اذا كان المصاب نائماً بعد انتهاء التشنجات ، وانتظر بجانبه حتى يفيق تماماً

تشنجات المرأة الحامل:

في حالة تشنجات المرأة الحامل تكون حياة الأم والطفل في خطر.

-أعط الإسعافات الأولية حسب الحاجة.

-انقل الحامل إلى أقرب مركز طبي فورا.

-أخبر الطبيب أن السيدة الحامل قد أصيبت بتشنجات.

الإسهال



تعريف الإسهال:

يحدث الإسهال عندما يتبرز الشخص ٣ مرات أو أكثر في اليوم ويكون البراز سائلا.

علامات دالة على خطورة الإسهال:

إسهال مستمر لأكثر من يومين.

-إسهال مائي.

-قيء مستمر.

-عطش مستمر.

-حرارة عالية.

-دم في البراز.

الإسعافات الأولية:

أعط الشخص المصاب كميات كبيرة من السوائل عن طريق الفم،إذا كان الطفل رضيعا فإعطه كميات أكبر من لبن الأم.

أمثلة السوائل:شوربة-ماء الأرز-محلول معالجة الجفاف.

كيفية إعطاء محلول الجفاف:

-يعطى معلقة من المحلول كل دقيقة

-إذا كان عمر المريض أكثر من سنتين يتم إعطاؤه رشفات متكررة من المحلول.

-إذا كان المريض يتقيأ فانتظر ١٠ دقائق ثم اعط ببطء أكثر أى كل ٣ - ٤ دقائق.

ملاحظة هامة:

يتم تحضير محلول معالجة الجفاف يوميًا ولا يحفظ لمدة أكثر من ٢٤ ساعة.

التعرض للحرارة الشديدة

ينتج عن التعرض للحرارة الشديدة ثلاث إصابات مختلف

الصدمة الحرارية (ضربة الشمس)

الإنهاك الحرارى (الإجهاد)

التقلصات العضلية

الصدمة الحرارية(ضربة الشمس)

تحدث نتيجة التعرض للشمس أو حتى فى الظل مما يؤدى إلى فشل ميكانيكية تنظيم درجة حرارة الجسم

الأعراض:

ارتفاع حاد فى درجة حرارة الجسم

الجلد ساخن وجاف

إنخفاض فى درجة الوعى

تشنجات أو إلتواء العضلات

الإسعافات الأولية :

تأكد أن المصاب يتنفس ولديه نبض.

ابدأ بإنعاش القلب والتنفس فورًا إذا لزم الأمر.

أبعد المصاب عن الجو الساخن.

ضع فوطا مبللة على جسم المصاب.

ضع المصاب فى تيار هوائى بارد.

ضع كمادات ماء بارد.

أطلب الإسعاف فورًا.

الإنهاك الحرارى

ينتج عن نشاط جسمانى فى درجة حرارة عالية تؤدى إلى عرق غزير دون تعويض الجسم.

الأعراض

حرارة الجسم تكون طبيعية أو مرتفعة قليلاً.

الجلد رطب بارد شاحب اللون.

دوخة ، صداع ، غثيان ، قيء ، تقلصات بالعضلات.

الإسعافات الأولية:

يعالج المصاب كأنه فى صدمة.

إعطاء المصاب محلول معالجة الجفاف أو ماء بارد.

التقلصات العضلية

تحدث نوبات متقطعة من التقلصات العضلية عادة بعد انتهاء التمارين الرياضية أو بعد العمل

انقل المصاب إلى منطقة باردة.

افرد أو مد العضلة برفق.

لا تقم بتدليك العضلة

اعط المصاب ماء بارد أو محلول معالجة جفاف أو محلول ملح.

إذا لم يحدث تحسن ، عامل المصاب كأنه مصاب بإنهاك حرارى.

التسمم بالمواد الكيماوية

الإسعافات الأولية في حالات التسمم بالمواد الكيماوية والمنظفات المنزلية

التسمم :هو دخول أي مادة ضارة (طبيعية أو مصنعة) أو ملوثة إلى الجسم بكمية معينة فتحدث أضراراً داخل الجسم.

المنافذ التي تدخل منها المواد السامة إلى الجسم:

البلع: عن طريق الفم والجهاز الهضمي.

الاستنشاق: أي عن طريق الجهاز التنفسي (مثل الغازات و الأبخرة السامة و أدوية التخدير الغازية.

الحقن: مثل لسع الحشرات أو حقن الأدوية بالجلد أو تحت الجلد أو الحقن العضلي أو الوريدي.

الجلد: عن طريق الامتصاص (مثل الدهانات و المواد الكيميائية)

يمكن تقسيم التسمم من حيث المسبب إلى:

تسمم بالأدوية.

تسمم كيميائي.

تسمم غذائي.

أعراض وعلامات التسمم:

يبنى التشخيص على أمور عديدة هي ظروف الحادث والمشاهدات المسجلة في مكان وقوعه ثم العلامات المرضية التي ظهرت على المصاب بالإضافة إلى نتائج التحاليل

(أ) ظروف الحادث وفحص المكان:

إن أكثر الأمور إثارة للشبهة بالتسمم هو حدوث أعراض مرضية حادة متشابهة عند أشخاص تناولوا طعاماً أو شراباً واحداً، وجود بعض المواد الكيماوية أو الدوائية السامة في الغرفة (يمكن ملاحظة رائحة غريبة أو مميزة أو لون سائل غريب)، أو وجود زجاجات فارغة تستعمل لحفظ هذه المواد أو وجود علبة الدواء قرب المصاب (أو تناثر أقراص الدواء بجانب المصاب).

(ب) العلامات المرضية:

١-الأعراض المعوية:

غثيان وقيء - آلام شديدة في البطن - إسهال

وللقيء رائحة خاصة مميزة مثل حالات التسمم بالسيانيد (رائحة اللوز المر) والفسفور العضوي (رائحة الثوم).

٢-الأعراض التنفسية:

وتتمثل في السعال والزرقة وضيق التنفس خاصة في حالات التسمم بالأبخرة والغازات المهيجة ،المعدل الطبيعي للتنفس في البالغين حوالي ١٦ مرة في الدقيقة.

٣-الأعراض الدماغية:

وتظهر نتيجة إصابة الجهاز العصبي المركزي وتأخذ أشكالاً متعددة:

الغيبوبة

التشنجات

الهياج (الهوس)

٤-أعراض التسمم بابتلاع المواد الأكالة كالأحماض المركزة و المنظفات
حروق على الفم و آلام شديدة بالبلعوم والصدر نتيجة لاحتراق المريء.

القواعد العامة لإسعاف حالات التسمم:

إن الهدف الأساسي من سرعة إجراء الإسعافات الأولية للمصاب بالتسمم هو تخفيف المادة السامة بأقصى سرعة ممكنة وطلب المساعدة الطبية والمحافظة على سلامة التنفس والدورة الدموية والوظائف الحيوية الأخرى لدي المصاب.

لكي يتم الإسعاف بصورة سليمة يجب مراعاة الآتي:

١-تأكد من عدم وجود خطر إضافي (عليك أو على المصاب) بسبب قيامك بإسعاف المصاب

٢-إذا كان ممكناً:

-حدد نوع السم أو الدواء أو الغذاء واحتفظ بوعائه وبقاياه أو غلافه.

-معرفة الجرعة أو المقدار المتعاطى من المادة.

-وقت التعاطي (أي كم من الوقت مضى على تناول المادة).

-عمر الشخص ووزنه.

٣-معرفة ما إذا كان التسمم عن عمد أم خطأ.

٤-ملاحظة الأعراض المصاحبة (سواء شديدة أو خفيفة).

٥-إذا وجد قيء يتم التحفظ عليه (ليسهل تحليله من الجهات المختصة).

٦-اتصل بمركز السموم أو المستشفى واحصل على النصائح الأولية .

٧-اطلب الإسعاف أو المعونة الطبية، أو انقل المصاب .

٨-وتأكد أن السم ووعائه في معية المريض إلى المستشفى.

٩-إذا كان فاقداً للوعي: يجب فحص التنفس تقديم الإنعاش القلبي الرئوي إذا لزم الأمر .

أهم الأسباب الشائعة لحالات التسمم:

١-السموم المنقولة من حاوياتها الأصلية إلى الزجاجات المنظفات والمطهرات المنزلية.

٢-إهمال الوالدين بترك المواد الخطرة في متناول الأطفال

٣-التخزين الغير صحيح للمواد السامة .

٤-استنشاق وابتلاع المواد السامة .

٥-عدم مراقبة الأطفال والإشراف عليهم .

٦-الرغبة في الانتحار .

تلوث الجلد أو العين بالمواد السامة

أولا: الإسعافات الأولية عند بلع المواد الكيماوية والمنظفات المنزلية

١-يراقب التنفس مع عمل تنفس صناعي إذا لزم الأمر.

٢-إعطاء لبن بارد وبياض بيضة.

٣-إعطاء مسكن قوي لتخفيف الألم.

٤-يمنع إحداث قيء للمصاب.

٥-يمنع غسيل المعدة.

٦.-يمنع إعطاء أحماض مثل الخل وعصير الليمون في حالات التسمم بالقلويات مثل الفلاش.

٧-ينقل المصاب للمستشفى فوراً.

ثانيا: **المواد المطهرة والمعقمة مثل الفينيك والديتول والفورمالين**
أن كثرة التعرض لهذه المواد سواء باللمس أو الاستنشاق قد يؤدي لحالات التسمم لذا يجب الحرص على تهوية المكان جيداً عند استخدام هذه المواد.
الإسعافات الأولية عند بلع المطهرات والمعقمات المنزلية:
١-في حالة تلوث الجلد يغسل بماء وفير ثم كحول ١٠% والأفضل بزيت الزيتون أو الخروع.
٢-في حالة شرب المواد المطهرة يفضل إعطاء شراب مقيئ (عرق الذهب) في حالة وعي المريض.
٣-ثم ينقل المصاب للمستشفى فوراً.

ثانياً: التسمم عن طريق الاستنشاق
تنتج كثير من حالات التسمم عن استنشاق بعض الغازات أو أبخرة السوائل السامة وتتميز حالات التسمم بالاستنشاق بسرعة وصول السم إلى الدم ومن ثم سرعة حدوث التسمم ... لذلك يراعى إسعاف المريض في هذه الحالة في أسرع وقت ممكن مع إتباع الإرشادات التالية:
١-ينقل المصاب فوراً من الجو المشبع بالغاز أو البخار السام إلى هواء نقي مع تحرير الجسم من الملابس الضاغطة وفك أربطة العنق.
٢-إجراء تنفس صناعي في حالة هبوط أو فشل التنفس، بعد إزالة الأشياء الموجودة بالفم وذلك على النحو التالي:
أ) إمالة الرأس المصاب الي الخلف وذلك لتفتيح المسالك الهوائية مع إغلاق فوهتي الأنف بالأصبع وأخذ شهيق عميق ووضع شفتي المعالج بإحكام فوق فم المصاب ونفخ الهواء في رئتيه، وذلك مع مراقبة صدر المريض الذي يرتفع عندما يصل الهواء الي داخل الرئتين.
ب) يرفع فم الشخص المعالج حتى يتمكن المريض من عملية الزفير مع مراقبة انخفاض الصدر
ج) تتكرر العملية السابقة حتى يستعيد المصاب تنفسه الطبيعي.
٣-تدفئة المريض إذا ظهرت عليه علامات البرد أو القشعريرة
٤-هدئ من روع المصاب بالتسمم إذا كان واعي لما حوله
٥-انقل المصاب فوراً إلى المستشفى.

ثالثاً: التسمم عن طريق الجلد
قد يتعرض الجلد للتلوث بإحدى المواد الكاوية ، التي تؤدي الى حدوث إصابات بالغه في الجلد ، ويجب أن نخلص الجلد من هذه المواد بأقصى سرعة ممكنة بإتباع التالي:
١-غسل الجلد بتيار من الماء المتدفق مع خلع ملابس المصاب والاستمرار في غسل الجلد بالماء أثناء خلع الملابس ،ثم يغسل الجلد بعد ذلك جيدا بالماء والصابون.
٢-عدم وضع أي دواء أو مادة كيميائية على الجلد المصاب وذلك لان بعض المواد الكيميائية قد تضاعف من إصابة الجلد.

رابعاً: التسمم عن طريق العين
الإسعافات الأولية المتبعة في حالات التسمم عن طريق العين:
١. فتح الجفنين باليدين مع غسل العين بما متدفق (يراعي ان يكون ضغط ماء الغسيل خفيف لمدة عشرة دقائق على الأقل).

٢-لا تستعمل أي نوع من القطرات
٣-انقل المصاب لأقرب مستشفى

الصابون والمنظفات الصناعية والشامبوهات

معظم الصابون المستخدم للتنظيف المنزلي غير سام نتيجة معادلة المواد القلوية المستخدمة فيه كذلك يستخدم محلول الصابون كمساعد للتقييز بديلاً لعرق الذهب في حالات التسمم إذا لم يتوفر الأخير. أما المنظفات الصناعية مثل (أومو - برسيل - تايد وغيرها) فإنها تحتوي على مواد عضوية وغير عضوية ومواد منعمة للغسيل وإنزيمات تسهل عملية التنظيف. وتعتبر هذه المنظفات أقل سمية من المنظفات الأخرى الشديدة القلوية مثل فلاش وكذلك مسلكات البالوعات إلى ١١. وقد يضاف للمنظفات مواد أخرى (PH) والتي قد يصل المعامل الهيدروجيني فيها مثل الكلوركس الذي يحتوي على ٣-٦% من هيبوكلوريت الصوديوم (bleaches) للتبييض الذي يتحول في المعدة - بعد اتحاده مع حمض الهيدروكلوريك - إلى حمض الهيبوكلوراس الذي له أثار موضوعية مهيجة للأغشية المخاطية للجهاز الهضمي، ولا يوصى بمعادلة هيبوكلوريت الصوديوم مع الأحماض أو القلويات الشديدة وذلك لأنه في هذه الحالة يتكون غاز الكلور أو غاز الكلورامين بالتبادل وهما من الغازات المهيجة للأغشية المخاطية وقد يؤديا إلى الاختناق.
أما الشامبوهات فهي قليلة السمية إلا من بعض الآثار المهيجة البسيطة للأغشية المخاطية ولكن بعض الشامبوهات تحتوي على مواد تمنع قشور الشعر مثل السيلينيوم الذي قد يؤدي إلى أعراض تسممية مع كثرة استعمال الشامبو أو ابتلاعه بطريق الخطأ.
بعض المطهرات ومزيلات العرق ومضادات البكتيريا تحتوي على مركبات الأمونيا الرباعية وهي مركبات شديدة القلوية وسامة (quaternary ammonium compounds).

إسعاف الطفل المصاب بارتفاع في درجة الحرارة

تعتبر درجة حرارة الطفل مرتفعة اذا كانت اكثر من ٣٧,٥ درجة مئوية ويكون ملمس جلدالطفل عندها حارا او يكون الطفل مصابا بالقشعريرة او التعرق ويفضل دائماقياس درجة حرارة الطفل وكإجراء اولي قم باعطاء الطفل احد الادوية الخافضة للحرارة التي يصفها طبيب الأطفال عادة وافضلها تحاميل السيتامول او شرابالبروفين ولا تعط الطفل الأسبيرين خاصة في حالات الكريب وجدري الماء وضع كمادات الماء البارد او الثلج او الكحول على جسم الطفل اما اذا كانتحرارة جسم الطفل مرتفعة بسبب تعرضه لاشعة الشمس لفترة طويلة فقم بنقل الطفلالى مكان اكثر برودة واعطه الكثير من السوائل وأخيرا تذكر دوما ان الحرارليست مرضا بحد ذاتها وانما هي احد اعراض المرض ولابد من مراجعة الطبيبلمعرفة سبب الحرارة خاصة اذا كان عمر الطفل اقل من ثلاثة أشهر.